

Fecha Última Actualización: 01-07-2022 11:55:01

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Mauricio Alfredo Cristi Greve
Edad : 59a 4m 17d
Dirección : Los Manzanos 2438

Rut : 9.473.897-0
Fecha Nacto: 14/02/1963
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1723320
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8475 4423

N° Epicrisis
313460

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)
Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 20/06/2022 19:24
Fecha Egreso : 01/07/2022 14:00

Días Estadía: 11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Síndrome Coronario Agudo Sin Supra St

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- Médicos: Cardiopatía coronaria: SCA en 2012 y 2016: stent en ADA tercio medio y distal, segmento proximal de ACx, Agosto 2021: SCA sin SDST, estenosis crítica ADA proximal y distal a stent de 1/3 medio + reestenosis de stent ACx - 2 DES (1/3 proximal y medio distal de ADA, PCI a ACx diferida), Oct 2021: DES ACx, EcoTT 11/8/21: VI no dilatado, paredes de grosor aumentado, FEVI 66%, sin alteración de la motilidad evidentes, AI y cavidades derechas normales. Sin valvulopatías ni signos de HTP. MIBI-D 18/2/22 con 11% isquemia residual de la pared anterior. FEVI 43-47%, ICC FEVI 40%, ERC Etapa IIIb (Crea Basal 1.9, 2022), DM2 NIR (HbA1C 8.1%), HTA, Adenocarcinoma prostático de alto riesgo - Gleason 3+3, en seguimiento. Tratado con RT + HT Degarelix completó 16 meses en 2019
- Quirúrgicos: 30/03/2022 CRM (LIMA a ADA y Puente aortocoronario con injerto de safena a ACD y puente aortocoronario con injerto de safena en ACx)
- Fármacos: Omeprazol 20 mg al día, AAS 100 mg al día, Atorvastatina 40 mg al día, Clopidogrel 75 mg al día, Amlodipino 5 mg cada 12 horas, Losartan 50 mg cada 12 horas, Carvedilol 12.5 mg cada 12 horas; Vildagliptina 50 mg cada 12 horas.
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ suspendido hace 10 años (IPA 45), OH (-), drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: 19/03/-04/04/2022 Insuficiencia cardíaca y posterior CRM (30/03/2022)
- Sociales: Vive con esposa e hijo en Puente Alto
- Inmunizaciones (influenza, neumococo, covid): COVID 3 Dosis, no Influenza

MOTIVO DE CONSULTA: Dolor torácico.

Paciente con antecedentes descritos, Consulta el día 20/06 por dolor torácico retroesternal opresivo irradiado al brazo izquierdo de EVA 10/10 que inicia a las 9 AM de más de 30 minutos de duración, niega la presencia de otros síntomas asociados. Al interrogatorio dirigido refiere la presencia de dolor torácico de similares características de aparición intermitente de EVA 2-3 desde hace aproximadamente 2 semanas previos al cuadro actual, Además de disnea de pequeños esfuerzos un mes posterior a la CRM.

Ingresa en regulares condiciones generales normocárdico, normotenso y afebril, sin compromiso de conciencia ni dificultad respiratoria ni hallazgos en su examen físico. Se evalúa con ECG en ritmo sinusal con Onda T negativa en DI y AVL que no muestra elevación del SST, y con curva de troponinas positiva, en este contexto se interpreta como SCA S/SDST, se decide hospitalización para estudio y manejo. Evaluado por UCO en urgencias determinan necesidad de agendar estudio coronario para el día 22/04 que no se realiza. Sin embargo evoluciona en buenas condiciones generales sin compromiso hemodinámico ni mayores conflictos se indica tratamiento con doble antiagregación y VDO.

Fecha Epicrisis : 01/07/2022 11:55

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 01-07-2022 11:55:01

Página 2 de 3

Se hospitaliza para completar estudio y determinar manejo

EXAMEN FÍSICO:

SV: PA 136/97 mmHg, PAM 109 mmHg, FC 80 lpm, FR 15 rpm, SatO2 99%, FiO2 Ambiental T 36.6 °C.

Peso estimado: 80 kilos.

Vigil, orientado en tiempo y espacio, atento, cooperador.

Bien hidratado y perfundido, mucosas hidratadas, llene capilar 2 segundos

Yugulares planas a 30°, Sin RHY

Tórax simétrico con herida de esternotomía cerrada sin presencia de lesiones adicionales RR2T SS, MP (+), sin ruidos agregados.

Abdomen blando, distendido, depresible e indoloro. RHA (+).

Sin edema de extremidades inferiores, sin signos de TVP, pulsos ++ simétricos.

EXÁMENES:

- Laboratorio: En hoja de exámenes.

- Microbiología: En hoja de exámenes.

IMÁGENES Y OTROS:

24/06: RxTx AP y Lateral: Imagen sin presencia de focos de condensación pulmonar sin presencia de lesiones óseas, Sin derrame pleural.

20/06: ECG de ingreso de superficie: RS 75 lpm, sin bloqueos, conducción AV sin alteraciones, buena progresión de QRS.

Inversión de Onda T en I y AVL.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

Dolor torácico de alto riesgo

- SCA S/SDST

- Killip I

ICC FEVI 40%

Antecedentes

EVOLUCION EN UTIM

CARDIOLÓGICO: Respecto a cardiopatía coronaria, se realizó PTCA 26-06 que mostró Estenosis de 80% LIMA a DA, PAC PL/CX Subocluido aortostial y estenosis en anastomosis distal 90%, PAC a CD Ocluido. Se realiza angioplastia a TCI/DA y CX. En el periodo inmediato posterior a PTCA evolucionó con dolor retroesternal EVA 7/10 irradiado a región interescapular, sin cambios electrocardiográficos. Se maneja con colchicina e isosorbide.

AngioTAC de tórax, abdomen y pelvis: sin signos de patología aórtica aguda, derrame pericárdico laminar que podría ser secundario a pericarditis. Paciente evoluciona sin dolor por lo que se suspende manejo sintomático.

El 28/06 tras episodio de esfuerzo (de vuelta del baño) presentó episodio de síncope sin dolor torácico ni disritmias documentadas. Impresiona ortostático (consideando perfil de presión arterial normal bajo de ese día e inicio reciente de antihipertensivos).

Evaluated por Cardiología, EcoTT y Holter se podría realizar de forma ambulatoria, y dado alto riesgo de reestenosis, se inicia Rivaroxaban en dosis bajas (por función renal). Respecto a factores de riesgo corregibles de cardiopatía coronaria registra Mayo 2022 Hb1Ac% 8.9, Junio 2022 CoIT 121 TG 186.

RENAL: Durante hospitalización con discreto deterioro de función renal, con evolución favorable hasta su basal. Cuenta con ecografía renal de agosto 2021 con signos de nefropatía médica bilateral. Se evitan nefrotóxicos, se mantiene seguimiento de laboratorio. Impresiona posible SCR tipo II dado cardiopatía conocida. Sin urgencia dialítica.

DIAGNÓSTICOS DE ALTA

IAM S/SDST Killip I.

- Estenosis de 80% LIMA a DA, PAC PL/CX Subocluido aortostial y estenosis en anastomosis distal 90%, PAC a CD Ocluido

- Angioplastia a TCI/DA y CX

- Cardiopatía coronaria. Múltiples stents, ACx, ADA (2012,2016 y 2021) y CRM marzo 2022 con LIMA a ADA y puente aortocoronario de safena a ACD y A.Cx.

Síncope de alto riesgo

Antecedentes

Fecha Epicrisis : 01/07/2022 11:55

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:53

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Diagnóstico de Egreso

Infarto agudo al miocardio -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinamia estable, afebril, sin requerimiento de O2.
Sin dolor torácico ni disnea, CF I.

Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen bajo en sodio, 200 g hidratos de carbono

Medicamentos

Omeprazol 20 mg al día vía oral
Ácido acetilsalicílico 100 mg al día vía oral
Clopidogrel 75 mg al día vía oral
Rivaroxaban 2.5 mg cada 12 horas vía oral
Losartan 50 mg cada 12 horas vía oral
Carvedilol 12.5 mg cada 12 horas vía oral
Atorvastatina 40 mg cada 24 horas vía oral
Duodart 1 comp cada 24 horas vía oral
Zopiclona 7.5 mg en la noche vía oral
Vildagliptina 50 mg cada 12 horas vía oral

Controles

- Solicitar control en CDT cardiología pasillo 8 con epicrisis impresa.
- Solicitar ecocardiograma transtorácico con orden impresa y epicrisis.
- Solicitar holter de ritmo con orden impresa y epicrisis.
- Continuar controles habituales con medicina general - consultorio.

Acudir a servicio de urgencias en caso de: dolor al pecho, dificultad respiratoria, desmayo, pérdida de conciencia, o en caso de estimarlo necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Victoria Polanco Trampe
Médico Tratante (Staff)